

시청 관점 코멘트



배변 이상은 과거 나뉘어 있던 '변비'와 '설사'가 합쳐진 항목입니다.

감별 진단 목록이 완전 다르기 때문에 환자의 주소를 듣고 나누어 생각해야 합니다. 두 항목 모두 **변의 양상**을 자세히 물어보는 것이 중요합니다. 또한 설사와 변

비 증례에서 **모두 내분비 질환(부신 및 갑상샘 질환)을 감별**하는 것을 잊지 말아야 합니다.

변비의 경우 기질성인지 기능성인지 감별하는 것이 중요합니다.

병력 청취 시 **수분 섭취, 식습관, 운동 여부, 약제 사용력**은 잊기 쉽지만 중요한 항목이니 잊지 마세요. 기질적 원인과 기능성 원인 여부를 감별해 향후 진단검사와 생활 습관 교육 또는 치료를 적절히 안내하는 것이 중요합니다. 중년 여성에서 잔변감, 질쪽으로 밀려나오는 느낌 등 증상을 호소하는 경우 직장류를 의심해야 합니다.

신체 진찰에서 **내분비 질환 중 갑상샘 질환을 감별하기 위해 목 진찰**을 해야 하며, 복부 진찰을 시행해야 합니다.

환자 교육 시 변비약을 장기간 복용하면 배변 반사신경이 둔화되므로 변비가 더 악화됨을 교육하는 것이 중요합니다.

변비의 경우 임상 술기로 항문 직장 진찰이 포함돼 있습니다.

설사의 경우 급성(2주 이내)과 만성(4주 이상)에 따라 의심해야 하는 질환이 달라집니다. 급성 설사의 경우 감염성과 비감염성 원인을 감별해야 하며, 만성 설사의 경우 기능성과 기질적(염증성 설사 등) 원인을 감별해야 합니다. 설사와 관련된 수분, 전해질 이상에 대한 치료 계획을 수립할 수 있는지를 평가합니다.

병력 청취 시 급성 설사의 경우 며칠 전 날 것 섭취 등 식습관을 확인해 식중독을 의심해 볼 수 있습니다.

신체 진찰 시 설사, 구토와 같이 체액이 소실되거나 어지럼, 실신 등 체액 부족 증상이 나타날 수 있는 모듈의 경우 **혀, 피부긴장도 등을 관찰해 탈수 정도를 평가**해야 합니다.

환자 교육 시 혈변, 심한 체중 감소가 동반되는 경우 기질적 원인을 의심해 대장내시경의 필요성을 설명하고, **설사량이 많은 경우 탈수로 인한 응급 상황이 생길 수 있음을 교육하는 것이 중요합니다**. 또한 **전해질 이상 여부도 의심 시 추가로 검사를 의뢰해야 합니다**. 또한 감염성 설사의 경우 치료로 항생제가 필요할 수 있다는 것과 **지사제의 남용을 자제하는 것을 꼭 언급**해주는 것이 좋습니다.

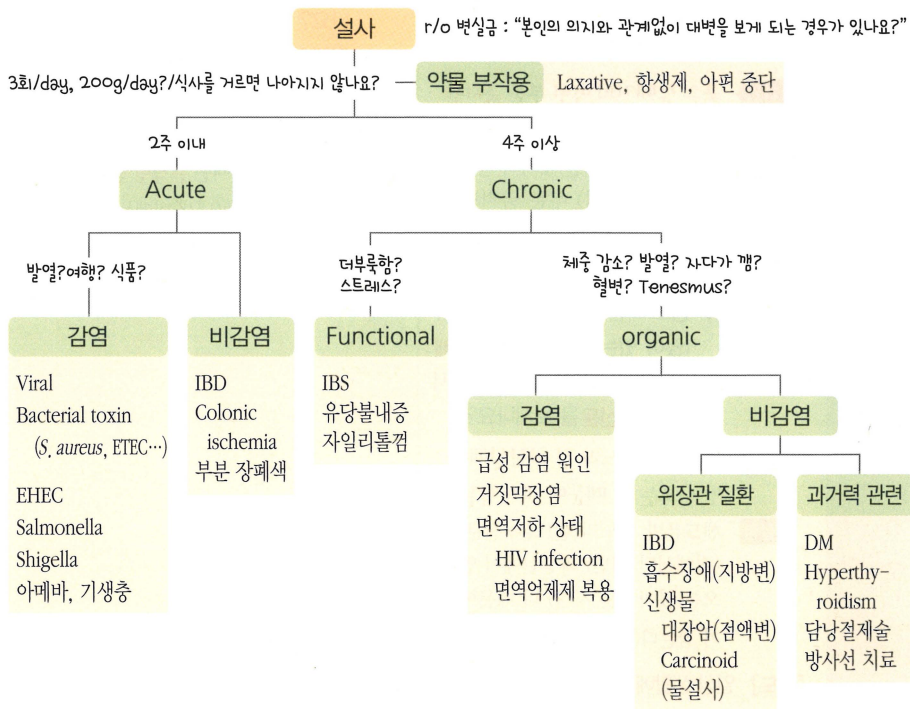
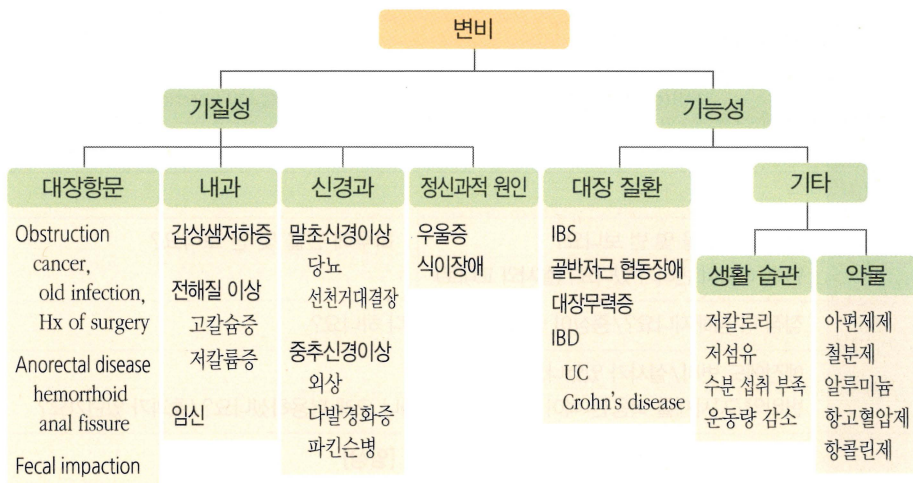
변비(Constipation)

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
변비	기능성 변비★ (functional constipation)	[병력] 젊은 여자, 평소 건강, 만성적, 저섬유성 식사, 수분이 적은 식사 [검진] DRE(항문 열상)	[검사] 단순 복부 방사선 촬영, 대장통과시간, 항문압 측정 [치료] 섬유소, 수분 섭취 증가, 규칙적 식사, 적절한 운동, 배변 습관 교정
	갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 추위불내성, 하지 부종, 피로, 식욕 저하에도 불구하고 체중 증가 [검진] 갑상샘 종대, 점액 부종	[검사] TFT [치료] 갑상샘호르몬 (levothyroxine)
	결장암★/직장암★	[병력] 혈변, 체중 감소, 대변 가늘어짐, 피로 [검진] DRE 상 종괴 촉지, 점액변, 혈변	[검사] 대장내시경, 항문경유초음파, 복부 CT/MRI [치료] 수술, 항암 치료, 방사선 치료
	과민 대장증후군★ (IBS)	[병력] 복부 팽만, 배변 후 복통 호전, 변비와 설사를 반복, 점액질 변, 잦은 트림, 방귀, 소화불량 [검진] 경미한 복통	[검사] 대변검사, 대장내시경, CBC [치료] 심리적 안정, 적당한 운동과 휴식, 진경제, 완하제
	약물 유발 변비	[병력] 아편제제, 철, 항콜린제, 항고혈압제(CCB), 항우울제 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 없음 [치료] 약물 중단
	신경 이상에 의한 변비	[병력] 치매, 파킨슨병, 척추외상 [검진] 신경학적 이상 소견(+)	[검사] 의심되는 신경계 질환 검사 [치료] 변비약
	직장류 (rectocele)	[병력] 잔변감, 질쪽으로 밀려나오는 느낌 [검진] 골반 내진 상 힘을 줬을 때 질쪽으로 덩이가 내려옴	[검사] 배변조영술, 대장내시경 [치료] 케겔 운동, 페서리(pessary), 수술적 치료

설사(Diarrhea)

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
기능성	운동 이상	갑상샘항진증 (hyperthyroidism)	[병력] 더위불내성, 체중 감소, 심계 항진 [검진] 갑상샘 비대, 갑상샘기능검사	[검사] TFT [치료] Propylthiouracil, Methimazole
		과민 대장증후군★ (IBS)	[병력] 복부 팽만, 배변 후 호전, 점액질 변, 잦은 트림, 방귀, 소화불량, 맵고 짠 음식, 기름진 음식, 스트레스 시 악화 [검진] 경미한 복통	[검사] 대변검사, 대장내시경, CBC [치료] 심리적 안정, 적당한 운동과 휴식, 식습관 교정, 진경제, 완하제
		약물 유발 설사	[병력] 항생제(거짓막대장염), 제산제, 삼투성 하제(변비약) [검진] 이상 소견 없음	[검사] 대변검사, 대변 <i>C. difficile</i> 독소검사 [치료] 약물 중단 및 교체
	삼투성	젖당불내성★ (lactose intolerance)	[병력] 우유 마시면 속이 불편함, 똥은 변 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 수소날숨검사, 젖당부하검사 [치료] 유당회피요법
기질성 (혈변 점액변 발열)	흡수 장애	단장증후군 (short bowel syndrome)	[병력] 이전 장절제 과거력 [병력] 이상 소견 없음	[검사] 복부초음파, 단순복부방사선 촬영 [치료] TPN, 지사제, Cholestyramine
	감염	식중독★ / 급성 위장염★ (acute gastroenteritis)	[병력] 음식물 섭취 후 72시간 이내, 구토, 복통, 발열, 탈수, 급성 설사 [검진] 복부 압통, 탈수 소견(맥박수 증가)	[검사] 대변검사, 대변배양검사 [치료] 수액 공급, 항생제 사용(일부)
	기타	염증성 장질환★ (IBD)	[병력] DRE 혈변, 심한 복통, 탈수, 체중 감소 [검진] 복부 압통, 장음 감소	[검사] 대장내시경, 대장조영술, 복부 CT [치료] 설파살라진, 스테로이드, Infliximab, 충분한 영양 공급
		결장암 / 직장암	[병력] 체중 감소, 혈변, 고령, 변비 동반 가능, DRE 상 종괴(+) [검진] 직장수지검사 상 종괴 가능	[검사] 대장내시경, 복부 CT, 복부 MRI [치료] 수술, 방사선 치료, 항암제
		허혈 결장염 (ischemic colitis)	[병력] 갑작스런 복통과 혈변, 기저 질환 [검진] 복부 압통	[검사] 대장내시경, 단순복부방사선 촬영 [치료] 수액 공급, 항생제, 금식

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

	변비(Constipation)	설사(Diarrhea)
O	언제부터 변비/설사가 시작되었나요?/갑자기 생겼나요?/아니면 계속 있었나요?	
L	-	
D	일주일에 변을 몇 번 보나요? 변 볼 때마다 변비가 있나요? (설사와 교대로)	하루에 변을 몇 번 보나요?
Co	점점 더 심해지나요?/증상이 좋아졌다 나빠졌다 하나요?	
Ex	예전에도 변비/설사가 있었나요? 변비약/지사제를 복용한 적이 있었나요?/얼마나 오래 복용하셨나요?/효과가 있던가요?	
C	[양상] 변 굵기/딱딱/색깔/변을 볼 때 힘을 과하게 주시나요?/손가락으로 변을 긁어내시나요?/변을 볼 때 항문이 막힌 느낌이 있나요?/배변 후에도 변이 남은 것 같은 느낌? 암기법 굵은 깔때기의 막힌 부분 긁지만 말고 딱 힘줘서 뚫어 설명 굵은(굵기) 깔(색깔)때기의 막힌(항문이 막힌 느낌) 부분 긁지만(손가락으로 긁음) 말고 딱 힘줘서(힘을 과하게 줌) 뚫어 [배변 습관] 평소 배변 습관은 어떠신가요? (앉아 있는 시간, 집에서만 배변, 오래 참는지)/화장실에서 핸드폰, 신문을 보시나요? 암기법 핸드폰만 보느라 집 화장실에서 안 나오는 너 때문에 내가 참는다. 설명 핸드폰만 보느라(핸드폰/신문) 집(집에서만 배변) 화장실에서 안 나오는(앉아있는 시간) 너 때문에 내가 참는다(오래 참음). [정도] 일상 생활에 불편을 많이 끼치나요?	[양상] 설사의 양/냄새/변이 물처럼 나오나요? - 수양성(장염, 식중독)/변이 끈적끈적하나요? - 점액성(IBS, IBD)/기름 같은게 떠 있나요? - 지방변(지방흡수장애) 암기법 양은냄비에는 끈적한 물과 기름이 설명 양(양)은냄(냄새)비에는 끈적한(끈적끈적) 물과(물처럼) 기름이(기름) [정도] 일상 생활에 지장이 있나요?

A	[전신] 피로/체중 변화(악성 증상) [소화기] 식욕 저하/구역/구토/설사/혈변(피의 양)/흑색변/복통(통증의 양상, 배변 후 나아지는지)/복부 팽만감/복부 종괴 [결장/직장암] 최근 배변 습관 변화 [항문] 항문 통증/항문 덩이 [폐쇄] 구역/구토/가스 배출이 안 되나요? [갑상샘 저하] 추위/더위불내성 피부 푸석푸석 [정신] 우울/수면장애(환자의 주관적 증상 일 수도 있으니 정신과적 질환) 암기법 사시사철 우수에 찬 눈빛 설명 사시사철(추위/더위불내성) 우수(우울/수면)에 찬 눈빛	[전신] 발열/오한/피로/식은땀/체중 변화 [탈수] 두근거림/호흡곤란/어지럼/소변량 감소(응급인지 알기 위해 필요) [소화기] 식욕 저하/구역/구토/변비/혈변(피의 양)/흑색변/복통(통증의 양상, 배변 후 나아지는지)/변실금(본인 의지와 상관없이 속옷에 대변이 묻어 있을 때가 있나요?)/뒤무직(배변 후에도 변이 남은 것 같은 느낌이 드나요?) [항문] 항문 통증 [갑상샘 항진] 더위불내성 [정신] 스트레스/우울/불안 [변실금] 속옷에 의지와 상관없이 대변 묻음
	최근 스트레스 받는 일이 있나요?	최근 드신 음식이 무엇인가요? (언제, 어떤 음식)/평소 안 드시던 음식을 드셨나요? 우유를 먹으면 더 심해지나요? (우유 꼭 언급) 최근 여행을 다녀오셨나요? 최근 스트레스 받는 일이 있나요?
E	이전 건강 검진 받은 적 있으세요?/위내시경, 대장내시경은 받으셨나요?/결과는 어땠나요?	
외	복부/항문/척추 다친 적 있나요? 복부/항문 수술하신 적 있나요?	복부를 다친 적 있나요? 복부를 수술하신 적 있나요?
과	이전에 진단받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/간질환/그 외 소화기 질환)	
약	현재 복용하시는 약이 있나요? (Opioid/철분제/항콜린제/항고혈압제)	현재 복용하시는 약이 있나요? (항생제/제산제/삼투성 하제)
사	술, 담배, 커피는 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요? [식습관] 평소 식습관에 대해 말씀해 주세요. - 맵거나 기름진 음식을 자주 드시나요?/식이섬유나 채소류는 많이 드시나요? - 물은 얼마나 드시나요? [운동] 하루에 운동은 얼마나 하시나요?	
가	가족 중에 대장암이나 변비를 가진 분이 계신가요?	가족 중에 현재 설사를 하는 분이 있나요? 가족 중에 대장암을 앓으신 분이 있나요?

여	[월경력] 규칙적/생리 주기/생리량/생리통	
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) 2. 구강 : 탈수 3. 목* : 갑상샘 촉진/경부 림프절 촉진(암, 감염성 질환) 4. 피부 : 피부 긴장도/하지 부종 [누워서] 5. 복부* : 시진 수술 흔적, 팽만/청진 5구역 3초간/타진 4군데 이상/ 촉진 알, 갇 촉진 ⊕ 시간적 여유 있을 때 : 간, 비장 타진 및 촉진 6. DRE : 직장수지검사 ☞ 실제 임상에서 진찰 시 복부 신체 진찰 시 타진으로 장폐색 여부, 촉진으로 종괴 여부를 확인해야 합니다. 시험장에서는 카드를 받을 수 있습니다.	
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음	
	1. 항문 직장 진찰	1. 정맥주사
	→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요? ☞ 변비/설사 증세 모두 DRE를 시행해야 하고 혈변, 종괴, 치핵 여부를 확인해야 합니다. DRE 모형이 없을 경우 술기를 간단하게 설명하고 DRE를 시행하기 위한 자세를 잡아주면 카드를 받게 됩니다.	

STEP 2 환자 교육

	변비(Constipation)	설사(Diarrhea)
공감	오랫동안 변비 때문에 많이 고생하셨을 것 같습니다.	설사 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 진찰들을 바탕으로 현재 기능성 변비가 가장 의심됩니다.	지금까지의 문진과 신체 진찰들을 바탕으로 현재 A질환이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 그 외에 기질적 원인에 의한 변비도 완전히 배제할 수 없습니다(암의 가능성 높다면 조심스럽게 언급).	하지만 그 외에 B질환, C질환도 완전히 배제할 수 없습니다.

검사	따라서 정확한 진단을 위해 복부 X-ray, 대장 내시경검사, 갑상샘기능검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요? [직장류 의심 시] 골반 내진을 통해 힘을 주셨을 때 질쪽으로 덩이가 확인돼 직장류가 의심됩니다. 직장류의 경우 추가적으로 배변조영술을 시행해 해부학적 이상을 관찰할 수 있습니다.	따라서 정확한 진단을 위해 대장내시경검사, 대변검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사로 기능성 변비로 확진되면 치료를 위해 생활 습관 개선이 가장 중요합니다.	A질환이 확진되면 치료를 위해 금식 or 항생제 or 약물 치료 등이 필요합니다. 또한 체액 부족이 있지는 않은지 탈수 정도를 평가해 수액 공급을 하고, 설사로 인해 전해질 이상이 관찰되면 이 또한 교정이 필요합니다.
예후	지금부터 치료를 잘 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.	
교육	[변비약 위험성] 정확한 진단이 되기 전까지 변비약의 사용에 있어 주의해 주셔야 합니다. 변비약의 경우에는 너무 많이 복용할 경우 오히려 이차성 변비가 생길 수 있기 때문에 증상이 심할 때만 짧은 기간 복용해 주시기 바랍니다.	[지사제 위험성] 지사제는 자주 사용하면 오히려 악영향이 있을 수 있기 때문에 정말 필요할 때만 쓰시는 것을 권장드립니다.
	[생활 습관 개선] 000님의 경우에 변비가 심하시기 때문에 식생활의 개선 및 운동이 필요해 보입니다. 규칙적인 식사를 하시고, 채소류를 많이 섭취하시고, 물을 충분히 마시세요. 또 하루 30분 정도의 유산소 운동도 변비를 치료하는데 도움이 될 수 있습니다. [배변 습관] 또한 변을 볼 때에 너무 힘을 주지 마시고, 아침 후 15~20분 정도를 변보는 것에만 집중하고 발뒤꿈치를 드는 자세를 취하면 변비 개선에 도움이 되리라 생각합니다.	[응급] 검사 결과가 나올 때까지 마음 편하게 가지시고 집에 돌아가셔셔도 설사를 또 하시다가 가슴이 두근거리고 어지럽고 숨쉬기 힘든 증상이 나타나거나 입술이나 혀바닥이 마른다면 탈수 증상이 심하다는 뜻이므로 바로 병원에 오셔서 수액 치료를 받으셔야 합니다. 그 외에도 고열이 나거나 변에서 피가 섞여 나오거나 복통이 너무 심한 경우에도 병원으로 바로 오시기 바랍니다. [과민대장증후군] 평소에 맵거나 짠 음식, 기름진 음식, 카페인은 장을 자극해서 설사를 유발하므로 삼가해 주시고, 술은 음식물이 장을 빠르게 지나가게 해서 설사를 유발하므로 이 또한 줄여주시는게 좋습니다.

[젓당불내증] 평소에 우유 섭취를 자제하면
증상 완화에 도움이 되실 것입니다.

질문 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

변비(Constipation)

❖ 기본적 진단 계획

- ① 직장항문기능검사 : 대장 통과 시간 측정, 직장항문내압검사, 배변조영술
- ② 혈액검사 : CBC, 전해질, TFT
- ③ 대장내시경, 대장조영술, 복부 X-ray, 복부 CT, 골반 MRI

❖ 치료 계획

- ① 식습관 개선 : 충분한 수분 섭취, 고섬유식이, 규칙적인 식사
- ② 배변 훈련, 심할 경우 하제(장기간 복용은 금지)
- ③ 약물 치료 : bulking agent, softner(MgO), osmotic(lactulose)

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 안심시키기★ : 변비는 기질적이 원인이 없는 경우가 90%이다. 대부분 수분 섭취, 운동, 섬유소 섭취로 호전될 수 있다.
- ② 생활 습관 개선★ : 섬유질 섭취 적고 운동량 부족 시 변비 뿐 아니라 게실 질환, 대장암, 치핵, 치열의 위험을 높임 → 금연/금주, 스트레스 관리, 충분한 수분 섭취, 섬유소 섭취, 규칙적 운동
- ③ 배변 습관 개선 : 오래 화장실에 앉아 있지 마세요. 아침 식사 후 15~20분 가량 힘 주지 않고 변을 보는 것에 집중하고 배변 시 똥꼬치를 드는 자세를 하면 배변에 도움이 됩니다.
- ④ 변비약 위험성 : 장기간 사용 시 정상적인 배변 위한 반사신경을 둔화시켜 수분과 전해질 손실 합병증, 과민성 대장염 등의 장 질환 및 대장 점막 착색 등 합병증 및 변비 악화 가능
- ⑤ 변비 합병증 : 치료하지 않을 시 치질, 치열, 장폐색 등이 발생할 수 있음

설사(Diarrhea)

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, electrolyte, TFT, 혈액 배양
- ② 대변검사 : 대변 배양, 대변 WBC
- ③ 영상검사 : 복부 X-ray, 복부초음파, 복부 CT, 대장내시경

❖ 치료 계획

수액 공급 및 전해질 교정(공통적)			
기능성	운동	갑상샘항진증 과민대장증후군 거짓막대장염	호르몬 안심시키기, 자극성 음식 회피 및 유제품 제한/loperamide 항생제 중단하고 vancomycin으로 변경
	삼투	젖당불내성	유당 회피
기질성	흡수	단장증후군	TPN(완전정맥영양), 지사제, Cholestyramine
	감염	식중독 급성 위장염(AGE)	수액 공급, 항생제(지사제 금기)
	기타	염증성 장질환(IBD) 결장암/직장암	입원, bed rest, sulfasalazine, mesalazine, steroid 수술, 방사선 치료, 항암제

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 요리하거나 음식물을 먹기 전에는 반드시 손을 씻고, 음식물을 제대로 데워서 먹어야 함을 교육
- ② 탈수가 심한 경우 병원에서 수액 치료를 받고 충분한 휴식을 취하면 호전됨을 안내
- ③ 지사제의 남용은 좋지 못하므로 꼭 필요한 경우에만 사용할 것임을 강조
- ④ 영양 공급 충분히 하되, 카페인, 알코올, 유제품 피하기
- ⑤ 원인 물질이 있는 경우 원인 물질 회피
- ⑥ 기질적 질환(혈변, 심한 체중 감소)이 의심되는 경우 대장내시경의 필요성에 대해서 설명
- ⑦ 급성 설사의 경우 대부분 자연 호전
→ But, 3일 이상 지속, 고열(>38.9℃), 혈변, 심한 복통, 탈수 있으면 즉시 내원(응급)

❖ 소아 감별 진단 코멘트

변비

소아의 경우 변비의 90% 정도가 기능성 변비이며, 기질적 원인으로 선천성 거대결장을 의심해야 합니다. 이 둘을 감별하기 위해 DRE를 통해 딱딱한 변이 촉진되면 기능성 변비, 비어 있으면 선천성 거대결장을 의심해야 합니다.

선천성 거대결장의 경우 CPX에 직접적으로 출제되기에는 어려움이 있다고 판단합니다.

설사

소아에서도 설사는 성인에서와 마찬가지로 급성과 만성으로 구분되며, 급성 설사는 염증성과 비염증성으로 감별 진단합니다.

만성 설사라면 만성 비특이설사, 유당불내증, 알레르기 직장결장염 등을 감별해야 합니다.

이 세 가지 모두 CPX에 출제되기는 어렵다고 생각합니다.



keyword

배변 이상 증례의 경우 변의 양상(굵기, 색깔, 양, 냄새, 수양성/끈적임/기름기 여부 등)을 자세히 묻고, 내분비 질환(부신, 갑상샘 질환)을 감별하는 것을 잊지 맙니다.

변비의 경우 기질성/기능성 원인으로 나눠 감별하고, 설사의 경우 2주/4주 기간으로 급성/만성을 감별해 급성 설사는 감염성/비감염성, 만성 설사는 기능성/기질성 원인을 감별합니다.

신체 진찰 시 갑상샘 질환 등을 진단하기 위해 목 진찰하는 것과 탈수 평가를 위해 혀, 피부 긴장도를 진찰해야 합니다. 전해질 이상이 의심 시 이 또한 추가 검사로 평가해야 합니다.

변비 keyword

수분 섭취 정도, 식습관, 운동, 약물력을 잊지 말고 확인합니다.

잔변감, 질쪽으로 밀려나오는 느낌 등 증상을 호소하는 경우 직장류를 의심해 골반 내진을 시행합니다.

급성		장폐색	A/N/V, 수술, 타(tympanic)
		대장암	고령, 체중 감소, 혈변, DRE(혈변)
만성	기능성	기능성 변비	젊음, 평소 건강, 저섬유식, 수분 섭취 ↓
		IBS	설사와 번갈아, 배변 후 복통 호전
		약물	항고혈압, 항콜린, 철, 아편
	소화기	치핵/치열	휴지에 피
		직장류	잔변감, 골반 내진
		IBD	젊음, 체중 감소, D, 혈변, 복통
	내분비	hypoT	갑상샘 증상

설사 keyword

급성 설사의 경우 **최근에 먹은 음식을 반드시 확인**해 감염성 설사 원인을 감별합니다.

교육 : 변비약, 지사제 과다 사용의 위험성을 알리고 남용을 자제하도록 교육해야 합니다. 식습관, 운동 등 생활 습관 개선과 올바른 배변 습관을 교육하도록 합니다.

응급 상황 교육 : 설사량이 많아 두근거림, 어지럼, 호흡곤란 등 탈수 증상이 나타나는 경우 바로 내원을 해달라고 합니다.

급성		식중독	탈수, 발열, N/V, 복통, 특이 음식
		허혈성 대장염	고령, 급성 복통, 혈변, 기저 질환
만성	기능성	과민대장증후군	스트레스 악화, 배변 후 복통 호전
		젖당불내성	우유
		약물 유발	항생제, 변비약
	소화기	염증성 장질환	젊음, 체중 감소, 혈변, 심한 복통
		대장암	고령, 체중 감소, 변비, 혈변
		단장증후군	장절제
	내분비	TT	TT 증상